# 내시경이 정상인데 왜 계속 쓰릴까요?

기능성·과민성 소화불량의 이해와 관리 — 약을 끊으면 재발하는 쓰림, 그 이유와 단계적 해법을 함께 봅니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 내시경이 깨끗한데도 증상이 있는 이유

뇌–장 상호작용 장애 — 눈에 보이는 상처가 아니라, 신경이 예민해진 상태입니다

### 내장이 예민해짐(내장 과민성)

정상이면 못 느낄 산·팽창 자극을 식도·위 신경이 통증으로 느낍니다.

### 위가 잘 늘어나지 않음(위 적응 장애)

음식이 들어와도 위가 잘 늘지 않아 조금만 먹어도 더부룩하고 금세 배부릅니다.

### 십이지장의 미세한 염증

내시경에 안 보이는 미세한 염증·변화가 신경을 더 예민하게 만듭니다.

### 꾀병이 아닙니다

신경·운동·미세 염증이 얽힌 실제 생리적 이상입니다. 그래서 산약만으로는 잘 안 듣고, 끊으면 재발합니다.



설명용 그림 · 뇌와 위를 잇는 신경 신호가 예민해진 상태 — 상처가 없어도 아프고 쓰릴 수 있습니다.

Tip · 상처(궤양·식도염)가 없어도 신경이 예민하면 똑같이 아프고 쓰릴 수 있습니다.

근거 · 로마 IV 기준 2016 · 뇌–장 상호작용 장애 분류

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 흔한 오해 세 가지 — 바로잡기

이 오해들 때문에 치료가 엉뚱한 방향으로 흐르기 쉽습니다

01

## “위산만 줄이면 낫는다”

산은 원인의 일부일 뿐입니다. 그래서 산약이 ‘조금’만 듣고, 끊으면 재발합니다.

**산과 함께 신경 과민도 다스립니다**

02

## “자다 깨는 건 저혈당 때문”

밤에 혈당이 떨어졌다 튀어 오르는 현상(소모기 현상) 같은 원인은 실제로는 드뭅니다.

**밤 증상은 대개 역류·신경 과민**

03

## “신경성 = 꾀병”

‘신경성’은 꾀병이 아니라 장 신경이 실제로 예민해진 의학적 상태입니다.

**의지가 아니라 치료가 되는 병**

Tip · 증상이 오래가도 스스로를 탓하지 마세요 — 치료 방향을 바꾸면 좋아질 수 있습니다.

근거 · 로마 IV 기준 2016 · 기능성 위장장애 환자 교육 권고

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 먼저 무엇을 확인하나요 — 필요한 검사

다른 병이 숨어 있지 않은지 확인한 뒤, 안심하고 과민성 치료로 넘어갑니다

| 검사 | 왜 하나요 |
|---|---|
| **식도 조직검사** | 내시경이 정상으로 보여도 호산구식도염(알레르기성 식도염)을 놓치지 않으려고 조직을 떼어 봅니다. |
| **헬리코박터 검사·제균** | 균이 있으면 없애는 것만으로 소화불량이 좋아지는 분이 있어 먼저 확인합니다. |
| **식도 산도·임피던스 검사** · 필요할 때 | 산성·비산성 역류와 증상이 함께 나타나는지 살펴, 증상이 산 때문인지 예민함 때문인지 가립니다. |
| **식도 운동(내압) 검사** · 필요할 때 | 식도 운동·삼킴 장애 같은 다른 원인을 함께 가려냅니다. |
| **위 배출 검사** | 식후 더부룩함·구토가 두드러질 때 위가 비워지는 속도를 확인합니다. |

**왜 검사하나요** '병을 찾으려고'가 아니라, 위험한 병을 배제하고 안심하기 위해서입니다.

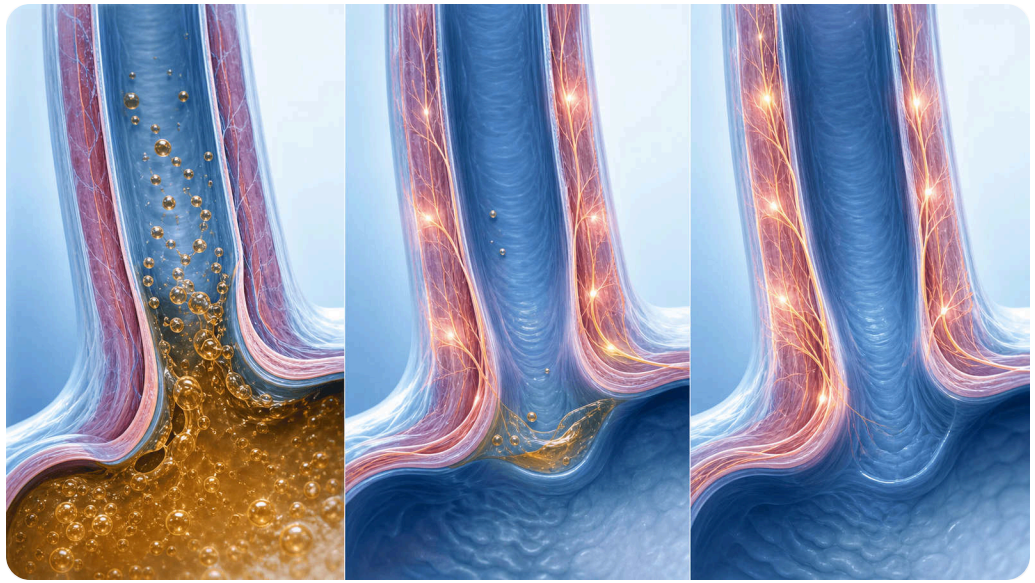
Tip · 모든 검사를 다 하지는 않습니다 — 증상에 맞춰 필요한 것만 합니다.

근거 · 난치성 위·식도 증상 평가 권고 · 식도 조직검사 · 식도 산도·임피던스 검사 · 위 배출 검사

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 같은 '쓰림'도 세 가지 유형으로 나뉩니다

유형에 따라 치료가 달라집니다 — 그래서 구분이 중요합니다



설명용 그림 · 왼쪽부터 산이 많은 경우, 산은 적은데 신경이 예민한 경우, 산이 거의 없는데 신경이 예민한 경우입니다.

**1 진짜 산 역류** — 산약이 잘 들음

위산이 실제로 많이 올라옵니다. 내시경은 정상이지만 식도에 산이 닿는 시간이 늘어난 상태(비미란성 역류질환)입니다.

**2 역류 과민성** — 신경 조절이 핵심

산이 닿는 양은 정상인데, 정상 범위의 역류에도 예민하게 반응해 쓰림을 느낍니다.

**3 기능성 가슴쓰림** — 신경·행동 치료 중심

증상이 산과 거의 관계없습니다. 식도 신경의 과민이 주원인이라 산약보다 신경·행동 치료가 중심입니다.

Tip · 유형은 필요할 때 식도 산도·임피던스 검사로 산성·비산성 역류와 증상의 관계를 보고 가립니다.

근거 · 로마 IV 식도 질환 분류 2016

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 치료의 큰 그림 — 발상의 전환

안 들으면 '더 센 산약'이 아니라, '다른 종류의 치료'로 방향을 바꿉니다

### 1단계 — 산약을 '제대로'

식사 30분 전에 먹기 · 필요하면 아침·저녁으로 나눠 밤 증상까지 덮기 · 그래도 부족하면 더 빠르고 강한 칼륨경쟁적 위산억제제로 바꾸기.

### ? 여기까지 했는데도 남는다면

'산이 부족해서'가 아니라 신경이 예민해서일 가능성이 큽니다.

### 2단계 — 방향 전환

더 센 산약 ✕ — 산을 더 줄여도 예민함은 그대로입니다. 신경을 다스리는 약 ○ · 호흡·수면·식사 같은 생활·행동 교정 ○.



설명용 그림 · 산약 길에서 신경·생활 치료 쪽으로 방향을 바꾸는 갈림길입니다.

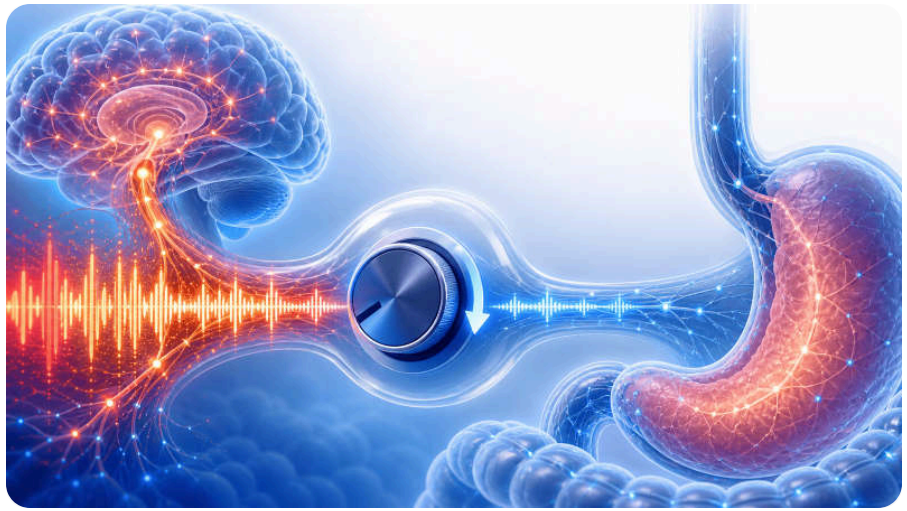
Tip · "약을 끊으면 재발"한다면 — "신경 과민을 다스리는 치료로 전환"이 회복의 갈림길입니다.

근거 · 난치성 역류·기능성 소화불량 단계적 치료 권고(위산억제제 최적화 → 신경조절)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 신경을 다스리는 약 — 예민해진 신경의 '볼륨'을 낮춥니다

우울증 치료가 목적이 아닙니다 — 우울증 용량보다 훨씬 낮은 용량으로 시작합니다



설명용 그림 · 신경을 끄는 것이 아니라, 너무 크게 켜진 통증 신호의 볼륨을 낮추는 약입니다.

### 통증·타는 느낌이 주된 경우

저용량 삼환계 약(아미트립틸린) — 통증 신호 자체를 무디게 해 쓰림·타는 느낌을 줄입니다. 잠들기 전에 적은 양으로 시작합니다.

### 더부룩함·일찍 배부름·체중 감소가 주된 경우

미르타자핀 — 입맛·메스꺼움·일찍 배부름에 도움(체중이 빠질 때 이점) · 부스피론 — 위가 잘 늘어나게 도와 식후 팽만 완화 · 아코티아미드 — 위 운동을 도와 식후 불편 감소

### 효과는 2~4주에 걸쳐

증상 '유형'에 맞춰 약을 고르고, 효과는 보통 2~4주에 걸쳐 서서히 나타납니다.

Tip · 효과가 서서히 나타나므로 스스로 끊지 말고 진료 때 상의하세요.

근거 · 로마재단 신경조절제 보고서 2018

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 약의 부작용과 주의할 점

적은 양으로 시작해 천천히 올립니다 — 지금 드시는 약을 모두 알려 주세요

| 약 | 흔한 부작용 · 주의 | 먹는 법 |
|---|---|---|
| **아미트립틸린 (삼환계)** | 입 마름·변비·졸림·체중 증가·일어설 때 어지러움, 드물게 소변보기 어려움·녹내장 악화, 많은 양에서 심전도 변화. 어르신·심장병이 있으면 낙상 주의 | 잠들기 전 적은 양으로 시작, 천천히 올림 |
| **미르타자핀** | 졸림·식욕 증가·체중 증가(체중이 빠지는 분에겐 오히려 도움), 드물게 백혈구 감소 | 잠들기 전, 혈액 이상이 있으면 점검 |
| **부스피론** | 어지럼·두통·메스꺼움. 자몽·일부 무좀약(케토코나졸)과 상호작용, 일부 우울증약(MAO 억제제)과는 함께 쓰지 않음, 세로토닌 증후군 주의 | 비교적 순함, 식전에 먹어 위가 잘 늘어나게 |
| **아코티아미드** | 대개 잘 맞음. 가벼운 설사·메스꺼움, 드물게 간 수치 상승 | 식전, 필요하면 간 수치 확인 |

Tip · 가벼운 부작용은 연락해 용량을 조정합니다 — 고열·혼란·근육 경직이 생기면 약을 멈추고 바로 응급실로 가세요.

근거 · 각 약 허가사항 · 로마재단 신경조절제 보고서 2018

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 상황에 맞춰 더하는 보조 선택지

증상과 상황에 맞춰 골라 더하는 보조적인 방법입니다

01

## 위장운동 촉진제

이토프리드·모사프라이드·아코티아미드 — 위가 잘 비워지게 도와 식후 더부룩함·일찍 배부름을 줄입니다.

**식후 더부룩할 때**

02

## 알긴산 제제(가비스콘)

식후 위 윗부분에 뜨는 산 주머니를 막아 식후 역류·쓰림을 빠르게 가라앉힙니다.

**식후 쓰림이 심할 때**

03

## 바클로펜

잦은 트림·되새김이 함께 있을 때 더해 봅니다. 식도 아래 조임근이 풀리는 것을 줄입니다.

**트림·되새김이 있을 때**

04

## 헬리코박터 제균

감염이 확인되면 제균합니다. 일부 환자는 제균만으로 소화불량이 좋아집니다.

**감염이 확인되면**

Tip · 보조 약은 주 치료를 돕는 역할입니다 — 증상에 맞는 것만 골라 씁니다.

근거 · 보조 약 권고(위장운동 촉진제·알긴산 제제·바클로펜) · 헬리코박터 제균

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

# 생활습관 — '끊을 음식이 없다'가 '할 게 없다'는 아닙니다

금지 음식 목록보다 신경을 안정시키는 습관이 더 중요합니다 — 우선순위 순서대로

### 1 · 횡격막(복식) 호흡 — 특히 식후

이 유형에서 무작위 대조 연구로 근거가 있는 유일한 방법입니다. 식후 천천히 배로 숨 쉽니다.

### 2 · 충분한 수면

잠이 부족하면 통증이 더 예민해집니다. 규칙적인 수면이 곧 치료입니다.

### 3 · 조금씩·천천히·기름기 적게

조금씩 천천히, 기름진 음식은 줄이고, 저녁은 잠들기 3시간 전까지 마칩니다.

### 4 · 2주 식품일기 쓰기

'내' 유발 음식을 기록으로 찾습니다. 배가 많이 부풀면 저포드맵 식사 4주 시도를 진료 때 상의하세요.

### 5 · 밤 증상이 있으면

침대 머리 쪽을 10~15cm 올리고 왼쪽으로 누워 자면 밤사이 역류가 줄어듭니다.

### 알아 둘 점

정상 체중이면 체중 감량은 해당되지 않습니다. 생활습관 교정의 근거는 전반적으로 약한 편이라, 약물 치료를 돕는 보조 축으로 함께 합니다.

Tip · 저포드맵 식사는 장에서 발효되기 쉬운 탄수화물을 줄이는 방법입니다 — 모든 분에게 효과가 있지는 않습니다.

근거 · 횡격막 호흡 무작위 연구 · 수면–통증 연관 · 식사 유발 음식·저포드맵 · 밤 역류 자세

# 행동·심리 치료 — 신경 과민을 직접 낮춥니다

약에 못지않게 효과가 오래갑니다 — 뇌–장 연결을 직접 다스리는 방법입니다

### 횡격막 호흡 훈련

배로 천천히 쉬는 훈련을 반복하면 자율신경이 안정되고 식후 역류·트림이 줄어듭니다.

### 인지행동치료 · 장 지향 최면치료

예민해진 뇌–장 회로를 다시 길들이는 치료입니다. 약물에 견줄 만하고 효과가 오래 갑니다.

### 스트레스·자율신경 관리

규칙적인 생활·이완·가벼운 운동으로 스트레스를 낮추면 장 신경의 예민함도 함께 가라앉습니다.



설명용 그림 · 배에 손을 얹고 천천히 숨을 들이쉬면 배가 부풀어 오릅니다 — 복식호흡 자세입니다.

Tip · 호흡 훈련은 오늘부터 집에서 바로 시작할 수 있습니다.

근거 · 뇌–장 행동치료(인지행동치료·장 지향 최면) 권고 · 호흡 훈련

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 단계별 관리 — 한 단계씩 차근차근

조급해하지 않고, 함께 한 단계씩 올라갑니다

**1**

## 위험 신호 확인

**다른 병 배제**

위험 증상을 점검하고, 식도 조직검사·헬리코박터 검사로 숨은 병을 먼저 가려냅니다.

**2**

## 산약 제대로

**최적화**

식전 30분·나눠 먹기·칼륨경쟁적 위산억제제로 바꾸기까지. 그래도 남으면 다음 단계로.

**3**

## 유형 확인 + 신경 약

**적은 양부터**

유형을 확인하고, 증상에 맞는 신경조절제를 적은 양으로 시작합니다.

**4**

## 행동·생활 교정

**어려우면 의뢰**

호흡·인지행동치료·생활 교정을 함께 하고, 그래도 어려우면 전문 진료로 연계합니다.

**핵심** 산약만 계속 올리지 말고, 제대로 써도 남으면 신경을 다스리는 약·행동 치료로 방향을 바꿉니다.

Tip · 한 번에 끝내는 약은 없지만, 단계를 밟으면 좋아질 수 있습니다.

근거 · 로마 IV 기준 2016 · 난치성 기능성 소화불량·식도 과민성 단계적 진료 흐름

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 꾀병이 아닙니다 — 함께, 단계적으로

단계적으로 좋아질 수 있습니다 · 처음 진단받은 분은 한 장 안내문을 함께 보세요

## 광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

## 이런 신호는 넘기지 마세요

피를 토하거나 검은 변은 바로 응급실로. 체중 감소 · 삼키기 어려움 · 빈혈 · 멎지 않는 구토는 '과민성'으로 넘기지 말고 바로 검사합니다.

## 참고한 자료

로마 IV 기준 2016(뇌–장 상호작용 장애 분류) · 로마재단 신경조절제 보고서 2018 · 각 약 허가사항 · 난치성 위·식도 증상 평가·치료 권고

SCAN TO REVISIT

**집에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요